ngừa tối thiểu một liều vắc xin polysaccharid 23 dòng phế cầu khuẩn có thể được tiêm thêm tối thiểu một liều Prevenar 13 (xem mục 5.1).

Ở những người cấy ghép tế bào gốc tạo máu (HSCT), liệu trình tiêm chủng khuyến cáo bao gồm bốn liều Prevenar 13, mỗi liều 0,5 ml. Liệu trình cơ bản bao gồm ba liều, liều thứ nhất được cho dùng trong khoảng từ 3 đến 6 tháng sau khi cấy ghép với khoảng cách tối thiểu 1 tháng giữa các liều. Liều thứ tư (liều nhắc lại) được khuyến cáo cho dùng 6 tháng sau liều thứ ba (xem mục 5.1).

Cách dùng

Tiêm bắp. Nơi tiêm ưu tiên là cơ nằm ở mặt trước bên của đùi (cơ đùi ngoài) ở trẻ sơ sinh hoặc cơ delta của phần trên cánh tay ở trẻ em và người lớn.

4.3 Chống chỉ định

Quá mẫn với các hoạt chất, với bất kỳ tá dược nào được liệt kê trong mục 6.1, hoặc với giải độc tố bạch hầu (diphtheria toxoid).

Cũng như với các vắc xin khác, nên hoãn cho dùng Prevenar 13 ở các đối tượng đang bị sốt cao cấp tính. Tuy nhiên, không nên trì hoãn việc tiêm chủng do đang mắc nhiễm khuẩn nhẹ, như cảm lạnh.

4.4 Cảnh báo đặc biệt và thận trọng khi sử dụng

Prevenar 13 không được tiêm vào mạch máu

Cũng như với tất cả các vắc xin tiêm, luôn luôn cần sẵn sàng giám sát và điều trị y khoa thích hợp phòng trường hợp xảy ra biến cố phản vệ hiếm gặp sau khi tiêm vắc xin

Vắc xin này không nên được tiêm bắp cho những người bị giảm tiểu cầu hay có bất kỳ rối loạn đông máu nào bị chống chỉ định tiêm bắp, nhưng có thể được cho tiêm dưới da nếu lợi ích tiềm ẩn vượt trội so với nguy cơ rủi ro (xem mục 5.1)

Prevenar 13 sẽ chỉ bảo vệ khỏi các týp huyết thanh *Streptococcus pneumoniae* có trong vắc xin và sẽ không bảo vệ khỏi các vi sinh vật khác gây bệnh xâm lấn, viêm phổi hay viêm tai giữa.

Cũng như với bất kỳ vắc xin nào, Prevenar 13 có thể không bảo vệ được tất cả các đối tượng đã dùng vắc xin phòng ngừa bệnh do phế cầu khuẩn gây ra.

Để có thông tin dịch tễ học mới nhất ở địa phương, nên tham khảo thông tin từ tổ chức quốc gia liên quan.

Những người bị suy giảm đáp ứng miễn dịch, bất kể do đang sử dụng liệu pháp ức chế miễn dịch, khiếm khuyết di truyền, nhiễm virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV), hoặc các nguyên nhân khác, có thể bị giảm đáp ứng kháng thể với tiêm chủng chủ động.

Có sẵn dữ liệu về an toàn và khả năng sinh miễn dịch cho một số ít người bị bệnh tế bào hình lưỡi liềm, nhiễm HIV, hoặc được cấy ghép tế bào gốc tạo máu (xem mục 5.1). Không có dữ liệu về an toàn và khả năng sinh miễn dịch của Prevenar 13 cho những người trong các nhóm bị suy giảm miễn dịch đặc hiệu khác (ví dụ: bệnh ác tính hoặc hội chứng thận hư) và việc tiêm chủng nên được xem xét trên từng cá thể.